

Czym jest *fobia specyficzna*

Kryteria DSM-5, statystyki, trzy elementy utrzymujące fobię. Pierwsza karta — do przeczytania na samym początku.

CZAS PRACY: 10 min **CHARAKTER:** psychoedukacja

ŹRÓDŁO: APA DSM-5 (2013); Wardenaar i wsp. (2017)

JAK UŻYWAĆ

Fobia specyficzna (kod DSM-5 300.29; ICD-11 6B03) to wyraźny, nieproporcjonalny *lęk* lub *unikanie* konkretnego obiektu lub sytuacji — trwający co najmniej 6 miesięcy i powodujący istotne cierpienie lub upośledzenie funkcjonowania. To **najczęstsze zaburzenie lękowe**: 7–9% populacji w danym roku, około 12% w ciągu całego życia.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wbrew częstemu odbiorowi („to dziecinada”, „przestań się bać”) fobia **nie jest słabością charakteru** ani brakiem dobrej woli. To zaburzenie z konkretnym mechanizmem powstawania i utrzymywania. Wardenaar i wsp. (2017, analiza WHO World Mental Health Survey): fobia powoduje upośledzenie pracy, relacji i codziennego funkcjonowania porównywalne z innymi zaburzeniami lękowymi. Nieleczona — rozszerza się, generalizuje, prowadzi do *narastającego unikania*. Leczona ekspozycją — remisja sięga 80–90%, a efekt utrzymuje się latami.

01 Sześć kryteriów diagnostycznych DSM-5

Do rozpoznania fobii specyficznej muszą być spełnione **wszystkie** sześć poniższych kryteriów. Zaznacz, które rozpoznajesz u siebie.

☐ **A · Wyraźny lęk** — przed konkretnym obiektem lub sytuacją (pająk, lot, krew, wysokość, winda).

☐ **B · Niemal natychmiastowy** — obiekt lub sytuacja prawie zawsze wywołuje lęk lub strach.

☐ **C · Aktywne unikanie** — lub znoszenie z intensywnym lękiem/cierpieniem.

☐ **D · Nieproporcjonalny** — lęk wykracza poza realne zagrożenie ze strony obiektu/sytuacji.

☐ **E · Trwałość** — objawy trwają co najmniej 6 miesięcy.

☐ **F · Cierpienie lub upośledzenie** — w pracy, relacjach lub codziennym funkcjonowaniu.

02 Liczby, które warto znać

~12%

ROZPOWSZECZENIE W CIĄGU ŻYCIA

Najczęstsze zaburzenie lękowe na świecie.

80–90%

SKUTECZNOŚĆ EKSPOZYCJI

Jeden z najwyższych wskaźników w psychoterapii.

2 · K : M

STOSUNEK PŁCI

Kobiety chorują dwa razy częściej (różnica społeczno-biologiczna).

03 Trzy elementy, które utrzymują fobię

Fobia nie utrzymuje się sama z siebie. Trzy mechanizmy działają w pętli: każdy karmi pozostałe. Zerwanie jednego osłabia całość.



Pętla: katastroficzna myśl → unikanie → brak korygującego doświadczenia → katastroficzna myśl rośnie. Zachowania zabezpieczające (np. telefon w kieszeni „na wszelki wypadek”, alkohol przed lotem) działają jak *subtelne unikanie wewnątrz sytuacji* — pacjent jest „w środku”, ale uczy się: „przeżyłem dzięki bezpiecznikowi”, a nie „przeżyłem bo nic mi nie grozi”.

04 ✓ Co działa, a co nie — krótka mapa

✓ CO DZIAŁA

Ekspozycja stopniowa *in vivo* · protokół jednej sesji
Östa · ekspozycja w wirtualnej rzeczywistości (VRET)
· eksperymenty naruszające oczekiwanie · usuwanie zachowań zabezpieczających.

✗ CO NIE DZIAŁA LUB SZKODZI

Rutynowe unikanie · rozmowy o lęku bez ekspozycji
· benzodiazepiny brane regularnie przed bodźcem ·
alkohol · przekonywanie się słowami („to nie jest
groźne”) bez doświadczenia.

Klucz: Fobia specyficzna jest jednym z **najlepiej leczących się** zaburzeń psychicznych. Pierwsza linia — *ekspozycja*, nie leki. Mózg potrafi nauczyć się nowego skojarzenia („obiekt jest bezpieczny”), ale nie nauczy się tego z rozmowy — tylko z doświadczenia. Dobra wiadomość: doświadczenie można zbudować stopniowo, krok po kroku, z asystą terapeuty.